



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : رحاب عبده حبيب يوسف
المحافظة : الجيزة
رقم البطاقة : 27802102103026 رقم التليفون : 01158123092
العنوان : ش محمد عرفه
العمر (تاريخ الميلاد) : 10-02-1978 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 21-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رحاب عبده حبيب يوسف National ID: 27802102103026	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



DMS
تاكسول وي ربو



04/01/2026

MDT FORM

Name: Youssef	MRN: 9185
Age: 48 Y	ID: 27802102103026
Menopausal Sta: POST MENOPAUSE	Phone: 01017173584
NRS SCORE:	Marital Status: M
BMI:	Family History: POSITIVE
CO Morbidity: FREE	Reason Of MDT: NEW CASE

Clinical Data:

BX: IDC
ER: 0 PR: 4 HER2: NOT AMP KI67: 60

R

L



Sonomammography:

LEFT UPPER OUTER LESION 27*19 MM WITH INFLAMMATORY SIGNS .ACASE OF INFLAMMATORY BREAST CANCER
NON SPESFIC L ND

Mets Workup:

FREE

History:

Recommendations:

FOR NEO advent then tt MRM

MDT Outcome & Plan

For:

1. Bone scan
2. Echo
3. Portacath insertion
4. Then start NACT; Taxol/Carbo x 12 weekly, followed by AC x4, with concomitant Keytruda "Keynote 522 protocol"....followed by LT MRM (Inflammatory on clinical examination).

T N M

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د. شيماء لاشين	د. هشام محمود	د. منى زكى			

Patient Name : الأستاذ / رهاب عبد حبيب	Request No. : 13004748
Patient No. : 27802102103026	Request Date : 28/01/2026
Path No. : 265/26	Verification Date : 17/02/2026
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Age : 47 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data

Left breast mass.

Nature of specimen

Tru cut biopsy collected on 28/1/2026, at 10:40 am

Gross examination

Four grey white tissue cores ranging in size from 1 cm up to 1.5 cm, totally submitted .

Technique:

- Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against: HER2/NEU (4B5), KI67 (30-9), PR (1E2), ER (SP1).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.
- * Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+ mitosis): (2+2+2) Grade 2
- * DCIS: Absent
- * Lobular Intra epithelial neoplasia : Absent
- * Angioinvasion: Absent .
- * Microcalcification :Absent
- * Perineural invasion: Absent
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
- * PR: Weak nuclear reaction in 20 % tumor cells (Allred score 4/8)
- * HER2: Moderate complete membrane reaction in more than 10 % of tumor cells (2+)
- * SISH :
- Average HER2 copy No.:2.95
- HER2/CEP17 ratio:1.4

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 24/02/2026 10:25:06

Page 1 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Patient Name	: الأستاذة / رحاب عبد حبيب	Request No.	: 13004748
Patient No.	: 27802102103026	Request Date	: 28/01/2026
Path No.	: 265/26	Verification Date	: 17/02/2026
Sex	: Female	Financial Category	: جوستاف رومي - مياد - هيازه
Age	: 47 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

* Ki 67: 60 %

Diagnosis

LEFT BREAST MASS, TRU CUT BIOPSY

-Invasive duct carcinoma Grade 2 (tubular differentiation 2, pleomorphism 2, mitosis 2)
(according to Nottingham grading system of breast cancer).

IPT:

- * ER: Negative (score 0/8).
- * PR: Positive (score 4/8).
- * HER2: score +2 (Equivocal)
- * SISH: Not amplified
- * Ki67: 60 %
- * Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations, 2010 Allred score: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

* Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendations, 2013.IHC 0: as defined by no staining observed or membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells .IHC 0+:as defined as incomplete membrane reaction in less than 10 % of tumor cells . . IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within < 10%of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is incomplete, intense < 10% of tumor cells.

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 24/02/2026 10:25:06

Page 2 of 3

Printing By : marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأستاذة / رحاب عيد حبيب	Request No. : 13004748
Patient No. : 27802102103026	Request Date : 28/01/2026
Path No. : 265/26	Verification Date : 17/02/2026
Sex : Female	Financial Category : جوستاف روسي - مبادره
Age : 47 Y	Department : Out Patient
Referreing Doc :	Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

ISH groups:

The ratio is calculated and the results is interpreted as:

- Group I (Positive): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4.
- Group II (Negative): HER2/CEP17 ratio is more than 2 & Average HER2 copy number/ cell is less than 4. (Recounting give the same result).
- Group III (Positive): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 6 (Recounting give the same result).
- Group IV (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2 & Average HER2 copy number/ cell is more than 4 but less than 6. (Recounting give the same result). Presidential Initiative for Women's Health- Pathology Lab Templates
- Group V (Negative): HER2/CEP17 ratio is less than 2

Signature

Prof .Dr.Gamal Abdel Atty
Dr.Walaa Ibrahim Ghoneim
Dr.Heba El-Shafeey

Verified by :

Dr.Heba Hasan

Printing Date : 24/02/2026 10:25:06

Page 3 of 3

Printing By : .marwa mohamed youss



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient ID: 927C	Patient Name English: Rehab Abdo Habib Youssef
٩٢٧٠ ١١ شهر	2026/01/19 11:41:19 AM :Report Date

Women's Health Outreach Program
Full Field Digital Mammography And Ultrasonography Examination of
both breast

Clinical Summary: left breast lump

Detailed Findings

Right breast

- Scattered fibroglandular breast (ACR b).
- No masses, asymmetric densities, distortion or suspicious clusters of micro calcifications.
- **Ultrasound** revealed heterogeneous breast parenchyma with prominent fibro glandular tissues giving mottled appearance
- No masses or cystic lesions identified
- Normal skin and nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Left breast

- Heterogeneous breast parenchyma with prominent fibro glandular tissues giving mottled appearance.
- 1 o'clock zone b hypoechoic well defined mass lesion with angular medial border measures 27x19mm with peripheral blood flow for biopsy
- No cystic lesions seen
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:

- **Right breast:** (BI-RADS 1) normal study
- **Left breast:** (BI-RADS 4a) atypical fibroadenoma for biopsy

*Much Obliged,
Dr. Marwa a. el seoud*